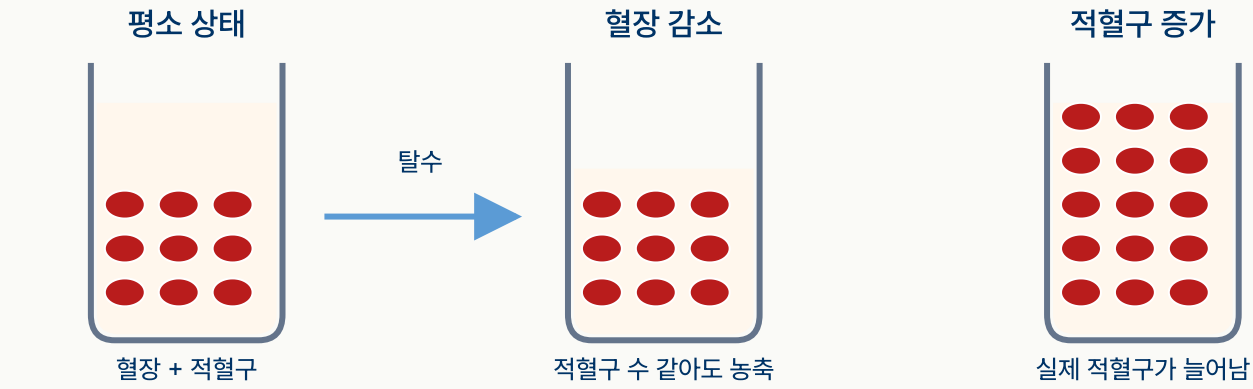
혈색소가 높다는 결과, 원인부터 살펴봅니다

혈색소(Hb)는 적혈구 안에서 산소를 나르는 성분입니다. 혈액이 농축되거나 적혈구가 늘면 높아집니다.

물이 줄었는지, 적혈구가 늘었는지



같은 양의 적혈구도 혈장(혈액의 액체 성분)이 줄면 농도가 높아집니다. 실제 적혈구가 늘어난 경우와 구분합니다.

강의의 혈색소 기준

성별	적혈구 증가증의 혈색소 기준
남성	**>16.5 g/dL**
여성	**>16.0 g/dL**

수치만으로 진성적혈구증가증(PV)을 진단하지 않습니다

탈수나 다른 원인으로도 높아집니다. 이전 검사와 비교하고 지속 여부·원인·다른 혈구 수치를 함께 봅니다.

검진 당일의 상황도 중요합니다

장정결 뒤 탈수로 일시 상승한 경우

대장내시경 장정결로 탈수가 생기면 평소 정상인 혈색소가 검진 날만 높아졌다가 재검에서 정상화되기도 합니다. 이를 상대적 적혈구 증가증이라고 합니다.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

생활·약물·검사 이력을 진료 때 함께 알려주세요

원인이 분명하지 않거나 높은 수치가 이어지면 혈액내과에서 추가 검사를 진행할 수 있습니다.

원인을 찾는 데 도움이 되는 정보

확인할 상황	혈색소가 올라가는 이유·진료
흡연 · 수면무호흡 · 심폐질환 · 고산 거주	산소가 부족하면 조혈호르몬(EPO)이 늘어 적혈구 생성을 촉진할 수 있습니다.
남성호르몬 투여 · 신장이식	이차성 적혈구 증가증의 원인이 될 수 있습니다.
SGLT2 억제제 당뇨약	**최은지 연자 Q&A:** 약 복용 전후 CBC를 비교합니다. 흡연 여부, 약의 적응증·이득도 함께 평가합니다.
원인 불명 · 백혈구·혈소판도 증가	EPO, JAK2 유전자, 필요시 골수 검사로 PV 등을 감별합니다. EPO를 분비하는 간·콩팥 종양 등도 원인에 포함됩니다.

이런 경과를 알리세요

1. 처음 높은지, 계속 높거나 상승하는지 이전 검사지를 비교합니다.
2. 손이 붉거나 저리고 아픔·가려움, 샤워 뒤 가려움이 있으면 알립니다.
3. **최은지 연자 Q&A:** 원인 없이 남성 **≥16.5**, 여성 **≥16.0 g/dL**가 지속되거나 상승하면 혈액내과 의뢰를 고려합니다.
4. **연자 Q&A:** SGLT2 억제제 복용 중 **18.5 g/dL** 같은 유의한 상승은 이차성 원인 평가와 EPO·JAK2 검사를 고려합니다.

치료는 원인에 따라 다릅니다

사혈이 모든 혈색소 상승의 치료는 아닙니다

이차성은 금연·수면무호흡 치료 등 원인 교정이 중심이고, 사혈의 이득은 불분명하다고 강의에서 설명했습니다. PV는 의료진이 저용량 아스피린·사혈과 약물치료를 정합니다. **연자 Q&A:** PV 사혈의 목표 적혈구용적률(Hct)은 **45%**이며 혈전 병력이 있으면 엄격하게 유지합니다.

아산 28회 연수강좌 — Hemoglobin(혈색소) 이상에 대한 접근(최은지)

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/hematology/high-hemoglobin-check-asan28/